Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caruaru

AV PORTUGAL, 1234, E-mail: vfpub02.caruaru@tjpe.jus.br, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, CARUARU - PE - CEP: 55016-400 - F: (81) 37199259

Processo nº **0017012-42.2022.8.17.2480**

AUTOR(A): AUCILEIDE GOMES E SILVA

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO

SENTENÇA

EMENTA: Constitucional, Administrativo, Civil e Processual Civil. Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada para o Fornecimento de Medicamento. Citação, contestação e réplica. Tutela antecipada indeferida. Anúncio de julgamento antecipado não impugnado pelas partes. Procedência do pedido vestibular, com concessão da tutela provisória de urgência antecipada nesta oportunidade e extinção da fase cognitiva do presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do C. P. Civil.

Vistos, etc.

AUCILEIDE GOMES E SILVA, já qualificada, através de advogado devidamente constituído, ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do MUNICÍPIO DE CARUARU, nos termos da inicial de ID 117372720.

Protocolizada em 17.10.2022, através do PJe.

Solicitação de apoio técnico (ID 117610568).

Nota técnica do **NatJus** (ID 118309318).

Intimação da Autora para se manifestar sobre a nota técnica (ID 118340330).

Petição requerendo a habilitação da advogada FABRÍCIA KARINE BARRETO, OAB/PE nº 25.100 (ID 120289171).

Requerimento de dilação de prazo para manifestação sobre a nota técnica (ID 120289883).

Concessão de prazo adicional (ID 120348247).

Manifestação sobre a nota técnica, com juntada de novo laudo médico (ID 126440586).

Solicitação de nova análise técnica (ID 126639566).

Segunda nota técnica dos autos (ID 130181997).

Não concedida a tutela antecipada (ID 130203723).

Petição informando o protocolo de agravo de instrumento (ID 132364131).

Não exercício de juízo de retratação (ID 132490991).

Contestação do ESTADO DE PERNAMBUCO (ID 134468911).

Petição do Demandado informando a existência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS (ID 138503721).

Réplica à contestação, com juntada de novo laudo médico (ID 143697270).

Solicitação de nova nota técnica, em virtude do novo laudo juntado aos autos, com posterior intimação das partes para manifestações, inclusive acerca de eventual requerimento de provas adicionais (ID 144059294).

Certidão registrando a impossibilidade de atendimento da solicitação do juízo pelo seu apoio técnico, em virtude de alegada falha no envio (arquivo corrompido) (ID 147359715).

Petição da Autora requerendo o julgamento do feito (ID 149522079).

Juntada do julgamento do agravo de instrumento, onde foi negado provimento, portanto mantida a decisão de não concessão da tutela de urgência deste juízo (ID 155862594).

Determinação de reenvio de solicitação de apoio técnico e anúncio de julgamento antecipado (ID 156056608).

Certidão informando uma nova ocorrência de problema técnico no envio do anexo para o **NatJus** (ID 164202190).

Reenvio de ordem e, ato contínuo, apresentação da terceira nota técnica do órgão auxiliar do juízo (ID 164202205 e 165053240).

Petição do Demandado requerendo a produção de prova, especificamente solicitando a participação do **NatJus** no feito (ID 167388880).

Manifestação da Autora sobre a terceira nota técnica do **NatJus** e reiteração do pedido de julgamento da lide (ID 167388880).

Conclusos. Decido.

Inicialmente, a declaração de hipossuficiência de recursos na própria petição inicial ou em declaração de pobreza garante aos interessados presunção de boa-fé quanto ao afirmado. Requisitos legais preenchidos. Incumbência da parte contrária

de demonstrar situação inversa, em desconstituição daquela presunção, de índole relativa. Logo, **DEFIRO** em favor da parte Demandante o benefício da Justiça Gratuita, nos termos dos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil em vigor.

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que não merece ser acolhida, pois a responsabilidade entre os entes federados pela saúde pública é solidária.

Neste sentido, destaco a tese firmada no **Tema 793 do STF**:

> **"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."**

Sobre o tema acima, destaco que a competência atribuída à autoridade judicial de direcionar o cumprimento e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro não se sobrepõe ao direito do Postulante em ajuizar sua demanda em face de todos ou de apenas um dos entes.

Assim, se não houver a formação do litisconsórcio passivo por vontade do Autor da ação, não cabe ao judiciário lhe impor tal conduta, forçando um litisconsórcio passivo necessário.

Agir desta maneira é ferir o direito do Postulante em ajuizar demandas em face de qualquer dos devedores solidários, regra de conhecimento notório no meio jurídico.

O direito de regresso existe, mas se o Postulante não promover sua ação em face dos entes federados conjuntamente, privilegiando apenas um deles, é dever do juízo, se reconhecido o direito da parte, determinar que o ente demandado cumpra a obrigação devida e este que busque os meios cabíveis para ser ressarcido pelo ente ao qual caberia a obrigação natural dentro da repartição de obrigações da estrutura administrativa.

Obviamente, caso a demanda seja ajuizada em face de mais de um ente, aí sim tem cabimento a aplicação, de ofício, da parte final do **Tema 793**, neste caso devendo o juiz fazer o direcionamento da obrigação ao ente responsável e, caso a obrigação tenha sido antecipada por outro ente, determinar o regresso em seu favor.

No entanto, no presente caso, não temos a formação de um litisconsórcio passivo, de modo que não se aplicam as disposições finais do **Tema 793**, motivo pelo qual não acolho a preliminar em questão.

Com relação à preliminar de incorreção do valor da causa, entendo que não há como se mensurar o valor econômico do feito pelo custo do tratamento médico vindicado, uma vez que não estamos tratando de uma relação privada (planos de saúde, etc.), mas sim de um pleito de custeio gratuito pelo Estado, de modo que o valor da causa nesta hipótese é inestimável, pois a lide se ampara no dever de garantia universal à saúde. Desta forma, acolho a preliminar suscitada e retifico o valor da causa para a importância de R$ 1.412,00 (Hum mil, quatrocentos e doze reais).

Assim, destaco:

> **AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.** 1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses. 2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000 reais. 3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguinte fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v. acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os

requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo, a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável". 4. A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022. 5. Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária.
(STJ - REsp: 2060919 SP 2019/0154461-4, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

No mérito, impende ser sublinhado que essa conhecida questão tem sido reiteradamente submetida ao crivo judicial, e a solução dada é pelo atendimento do pleito formulado, em casos como o da espécie, que tem base jurídica moral, legal e, sobretudo, constitucional.

O art. 196 da Constituição Federal, reproduzido pela Constituição Estadual em seu art. 159 (http://www.jusbrasil.com/topicos/10669784/artigo-153-da-constituição-federal-de-1988), dispõe:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Esse dispositivo constitucional constitui norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado, independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para legitimar a observância ao direito subjetivo material custodiado.

Nesse sentido, apresenta-se o entendimento doutrinário de Alexandre de Moraes:

> "A Constituição Federal (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111982551/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988), em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competências no tocante à proteção da saúde pública. No Preâmbulo da Constituição Federal (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111982551/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988) destaca-se a necessidade de o Estado democrático assegurar o 'bem estar' da Sociedade. Logicamente, dentro do 'bem estar', destacado como uma das finalidades do Estado, encontra-se a 'Saúde Pública'. Além disso, o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da 'dignidade da pessoa humana' como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das convenções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual".[1]

O direito à saúde também vem consignado na Lei nº 8.080 (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109386/lei-8080-90)/1990, que dispõe em seus artigos 2º (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11678464/artigo-2-da-lei-n-8080-de-19-de-setembro-de-1990), § 1º (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11678436/parágrafo-1-artigo-2-da-lei-n-8080-de-19-de-setembro-de-1990), e 6º (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11678015/artigo-6-da-lei-n-8080-de-19-de-setembro-de-1990), Inciso I (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11677980/inciso-i-do-artigo-6-da-lei-n-8080-de-19-de-setembro-de-1990), alínea d, *in verbis*:

> "Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
>
> § 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
>
> (...)
>
> Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
>
> I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;"

Cumpre consignar que incumbe ao Poder Judiciário, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes, mandar e fazer com que se cumpra a lei e a Constituição. Se o Estado-Administração não as cumpre, a própria Carta Magna indica a jurisdição como meio de forçar o cumprimento da obrigação (art. 5º, XXXV).

Há que se ressaltar que não houve concessão de liminar no feito diante das suas especificidades, onde em 2 (duas) oportunidades em que este juízo requisitou informações do seu órgão técnico auxiliar, recebera pareceres negativos diante da insuficiência de informações médicas apresentadas pela parte Autora aptas a permitir uma análise exauriente pelo corpo técnico competente.

No entanto, numa terceira oportunidade em que os autos foram remetidos ao **Natjus**, embora o parecer tenha sido não favorável ao pleito autoral, foi reconhecida a existência de evidência científica e da urgência do tratamento médico requerido pela Autora.

Para melhor elucidação, confira-se o trecho específico que trata dessa questão:

> "CONSIDERANDO que não foram encontradas nos relatórios médicos justificativa para a não utilização de todos os fármacos de alta eficácia disponíveis no PCDT-SUS, CONSIDERANDO que o relatório médico circunstanciado e fundamentado pelo médico assistente descreve todos os fármacos de primeira linha e inclui o fármaco Alentuzumabe nesta mesma classificação, o que não está de acordo com o reconhecido efeito terapêutico relacionado a este fármaco, CONSIDERANDO a justificativa de risco ao Natalizumabe apresentada no relatório, CONCLUI-SE que ainda faltam informações sobre a não utilização de Alentuzumabe de acordo com o algoritmo de tratamento do PCDT-SUS para pacientes com alta atividade da doença."

Ainda, confira-se trecho do laudo do médico assistente:

> "Tendo em vista a GRAVIDADE do quadro e que a paciente já apresenta SEQUELAS, está indicado uso de OFATUMUMABE (Kesimpta) como medicação para manutenção e controle de doença de base, a ser indicado de forma

PRECOCE e URGENTE, considerando que trata-se de doença potencialmente GRAVE e com potencial de SEQUELAS IRREVERSÍVEIS, havendo maior risco conforme ATRASO DE INTRODUÇÃO da medicação indicada. Pontuamos que o paciente apresenta positividade para o vírus JC, o que implica risco aumentado para Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP) com o uso de Natalizumabe, de forma que não há indicação no momento para uso de nenhuma outra terapia de plataforma ou primeira linha (interferons, glatiramer, tecfidera, azatioprina, teriflunomida, alentuzumabe) ou mesmo de outro anticorpo monocional que aumente o potencial risco de LEMP de forma que indicamos o uso seguro de Ofatumumabe para o paciente acima..."

Pois bem, analisando detidamente as opiniões médicas contrastadas acima, entendo que o órgão auxiliar do juízo considerou que a parte Autora não apresentou comprovação de que nenhuma das terapias ofertadas pelo SUS é adequada ao seu caso, motivo pelo qual opinou de forma desfavorável ao uso do fármaco postulado, este que não se enquadra naqueles fornecidos pelo sistema público de saúde. Houve ainda uma pequena questão quanto ao grupo em que uma determinada medicação rechaçada estaria inserida, pois não seria um tratamento de primeira linha, questão que me parece irrelevante posto que houve a negativa expressa do uso da medicação em si.

Lado outro, vejo que o laudo médico prestado pelo profissional que acompanha a Requerente foi bastante circunstanciado, explicando de forma bem minuciosa o motivo pelo qual passava a prescrever o novo tratamento, diante da gravidade e urgência do seu quadro de saúde e da inadequação das alternativas ofertadas na rede pública para as circunstâncias especiais do caso.

Assim, me convenço das ponderadas razões específicas prestadas pelo médico assistente da Postulante, pois é conhecedor das minúcias do seu tratamento, bem como, ainda, sendo constatado pelo próprio órgão auxiliar do juízo que há evidência científica e gravidade no caso posto.

Diante do quadro acima relatado, com finalidade de preservar o direito à vida e à saúde, consagrados constitucionalmente, em especial no artigo 5º, *caput*, e artigos 196 e 23, inciso II, da Carta Magna Republicana, que atribuem ao Estado-membro a responsabilidade solidária pela proteção à saúde da população, é medida que se impõe procedência do pleito autoral.

Finalmente, no que tange ao pedido de danos morais, entendo que não houve nenhuma conduta do Demandado que configurasse hipótese de dano indenizável na espécie. Ora, o Estado, como garantidor universal, não se desincumbiu de seu ônus de formular políticas públicas de saúde, o que por si só derroga o pleito autoral. Ainda, no caso específico, destaco que há uma extensa gama de tratamentos disponibilizados à Autora, no entanto, as condições específicas da sua enfermidade evoluíram de maneira a se revelar necessária uma prestação médica não contemplada nas políticas públicas existentes, o que, ao meu sentir, não reflete uma ofensa aos seus direitos de personalidade, portanto inexistindo dano moral.

ISTO POSTO:

Com fundamentos nos fatos e nos pilares constitucionais, legais e jurisprudenciais acima postos, **JULGO PROCEDENTE** o pedido deduzido na atrial formulado por **AUCILEIDE GOMES E SILVA**, para **CONDENAR o ESTADO DE PERNAMBUCO** ao fornecimento do medicamento **OFATUMUMABE**, pelo tempo e quantidade necessários a seu tratamento e de acordo com a prescrição médica.

No entanto**, CONDICIONO** a entrega do fármaco à apresentação trimestral de prescrição médica, na **FARMÁCIA DO ESTADO** responsável pela dispensação do citado medicamento, para aferir a necessidade de continuação do tratamento.

Por outro lado, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido de danos morais, pelos fundamentos já expostos.

Assim sendo, **DECLARO** a extinção da fase cognitiva do presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do C. P. Civil.

Reconhecendo, ainda, a urgência alegada, restam preenchidos os requisitos do art. 300, do **CPC**, de modo que **CONCEDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA** para que o Demandado cumpra com os termos deste julgado de forma provisória no prazo de 10 (dez) dias úteis deste *decisum*, **fornecendo-lhe a tal medicação para ministração por um prazo de 3 (três) meses consecutivos (art. 8º, da Recomendação n° 146/2023-CNJ), devendo a parte interessada, 15 (quinze) dias antes do fim do prazo, caso o remédio já não esteja sendo regularmente fornecido pela Farmácia do Estado de Pernambuco, apresentar em juízo, através do seu advogado ou Representante do Ministério Público, conforme o caso, um laudo médico atualizado indicando a**

necessidade de continuidade do tratamento (art. 7º, § 1º, da Recomendação nº 146/2023-CNJ), inclusive juntando 3 (três) orçamentos observando-se o PMVG (preço máximo de venda ao governo) (art. 9º, da Recomendação nº 146/2023-CNJ), oportunidade em que se intima o Estado de Pernambuco, pela forma mais célere, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, informe nos autos se o fármaco encontra-se disponível na Farmácia do Estado de Pernambuco. Após a referida manifestação ou no caso de certificação do decurso do prazo para tal, faça-se conclusão para os impulsos necessários.

Em caso de problemas com a adaptação do remédio ou de falecimento da parte Requerente, a medicação remanescente em sua totalidade (caixa lacrada ou já aberta) deverá ser entregue à Farmácia do Estado de Pernambuco, mediante recibo, ainda que a mesma tenha sido adquirida mediante bloqueio judicial neste processo.

Havendo necessidade de continuidade do tratamento, o procedimento acima indicado deverá ser reiterado na mesma sequência e observando-se os mesmos prazos.

Todos esses prazos começarão a ser contados a partir do dia útil seguinte ao da efetiva intimação, pela via mais rápida possível, no âmbito da tecnologia disponível e legalmente acolhida no Sistema Judicial vigente.

Caso a parte autora deixe de retirar o medicamento na farmácia do Estado ou de solicitar a renovação de bloqueio por 3 (três) meses consecutivos, restará configurada a hipótese de abandono do tratamento (art. 16, da Recomendação nº 146/2023-CNJ).

Destaco que os prazos e procedimentos adotados por este juízo possuem amparo principalmente na Recomendação nº 146/2023 do CNJ, bem como nas demais resoluções/enunciados competentes sobre a matéria.

Intime-se o (a) Secretário (a) Estadual de Saúde, bem como a Procuradoria Regional do Estado de Pernambuco, do inteiro teor desta sentença e para que adotem as providências necessárias ao cumprimento da liminar ora concedida, de tudo certificando-se nos autos, encaminhando em anexo a cópia desta.

A intimação dirigida à Procuradoria deverá ser cumprida por oficial de Justiça em regime de plantão, face à urgência que o caso requer, e a do Secretário Estadual de Saúde pelo meio que a Secretaria deste Juízo entender mais célere, ressaltando que cópia desta decisão servirá como ofício para os fins da segunda comunicação.

Considerando que a fundamentação do presente julgado se encontra lastreada em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 793), deixo de determinar a remessa necessária deste feito à instância superior com fulcro no art. 496, §4º, inc. II, do CPC.

Condeno o Demandado em honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.412,00 (hum mil, quatrocentos e doze reais), com amparo no art. 85, § 8º, do CPC.

P.R.I. - C U M P R A - S E.

Demais providências cabíveis.

Caruaru, 02 de maio de 2024.

JOSÉ ADELMO BARBOSA DA COSTA PEREIRA

Juiz de Direito

---

[1] MORAES, Alexandre de. Constituição (http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111982551/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988) do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo, Atlas, 2002, p. 1.904.

Assinado eletronicamente por: JOSE ADELMO BARBOSA DA COSTA PEREIRA
02/05/2024 16:54:49
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 169240528

24050216544820700000165239115

IMPRIMIR GERAR PDF